

区域卒中中心三年建设路线图

从急救网络到康复闭环,把「时间就是大脑」落到每一分钟。

本次汇报

1.

疾病负担

流行病学与现状

2.

诊疗路径

从识别到干预

3.

关键指标

疗效与安全

4.

现存问题

瓶颈与风险

5.

改进方案

下一步计划

6.

资源需求

投入与时间表

01

疾病负担

脑卒中的流行病学与临床现状

早识别、早干预, 是改变脑卒中结局的关键

时间窗决定神经功能的可挽救程度

脑卒中的四步管理

1.	早期识别	基于典型症状与量表快速筛查
2.	确诊分型	影像 + 电生理 + 抗体检测
3.	规范治疗	急性期干预与长期维持并重
4.	康复随访	功能评估与并发症防控

* 路径依据最新专家共识

发病机制与干预靶点

病理基础

- 神经元/髓鞘损伤
- 炎症与免疫异常
- 神经环路受累

关键指标(示例)

onset : 急性/亚急性
target : 免疫调节
window : 4.5h
score : mRS 0-2

综合管理的三个维度

1.

急性期

快速稳定,把握可逆的治疗时间窗

2.

维持期

预防复发,控制疾病活动度

3.

康复期

功能重建与生活质量提升

规范化管理前后

干预前

分散诊疗

- 识别延迟
- 路径不统一
- 随访脱节

干预后

闭环管理

- 快速通道
- 标准路径
- 全程随访

典型影像表现

脑卒中在 MRI/CT 上有其特征性征象,是确诊与分型的重要依据。规范化的影像采集与判读流程,能显著提升诊断一致性。

“影像必须结合临床与实验室,单一征象不足以定论。”

— 诊断规范

此处放置影像图

本年度诊疗数据

年接诊量

1,240 例

↑ 18%

确诊时间

3.2 天

↓ 0.8 天

规范治疗率

91 %

↑ 6 pt

年复发率

12 %

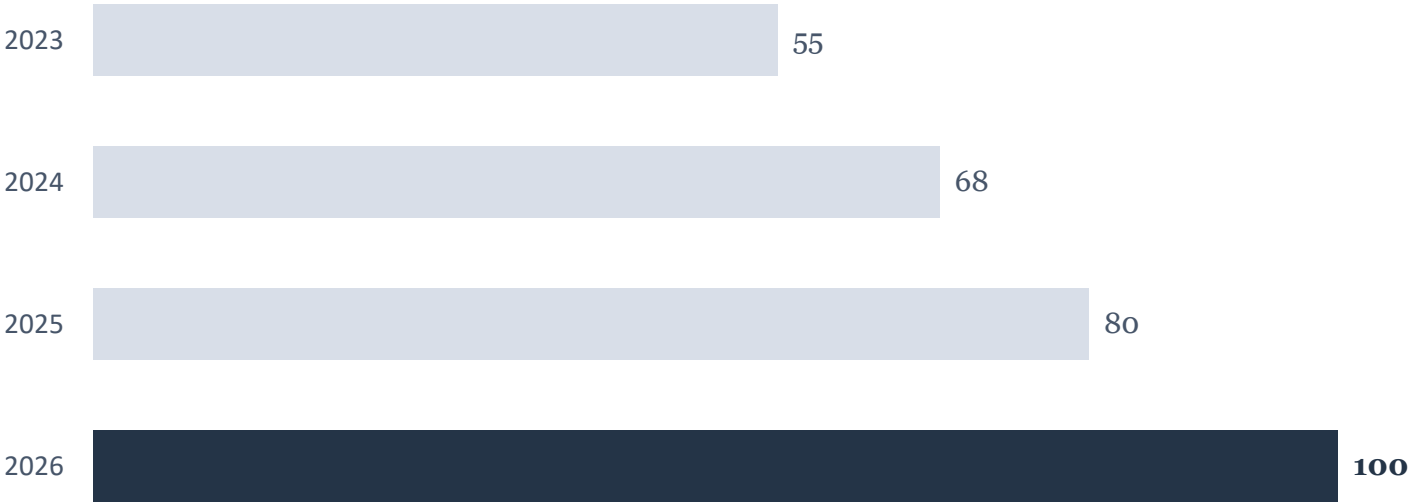
↓ 3 pt

脑卒中的核心疗效指标

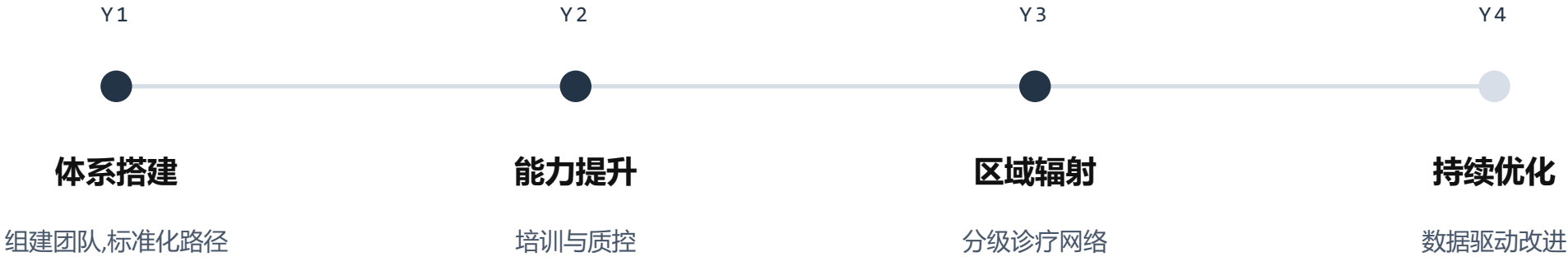
4.5 h

静脉溶栓时间窗

发病至给药每延迟 30 分钟,良好预后概率下降约 10%。缩短 DNT 是本项目的核心抓手。



三年建设时间线



分型与治疗方案

分型	占比	一线方案	预后
经典型	62%	标准治疗	良好
进展型	24%	强化方案	中等
难治型	14%	个体化	需随访

来源：科室登记数据 2026

资料来源: 科室临床数据 2026

急救绿色通道



让每一位脑卒中患者都得到规范诊疗

国家卒中中心建设 · 战略汇报

下一步 推进标准化路径落地